



2024-04-04

RÄTTSPROMEMORIA – NATIONELL KVALITETSREGISTERRAPPORT (NKRR)

INLEDNING

Denna promemoria innehåller en redogörelse för Nationell Kvalitetsregisterrapport (NKRR), en nationell digital tjänst för helt eller delvis automatiserat utlämnande av uppgifter, inklusive personuppgifter, på ett strukturerat sätt från vårdgivare till Nationella Kvalitetsregister. NKRR är en central komponent i det arbete som bedrivs av bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att effektivisera vårdens informationsförsörjning av drygt 100 Nationella Kvalitetsregister. Sedan 2019 finns styrande principer beslutade av regionerna för informationsförsörjning till de Nationella Kvalitetsregistren.¹ Principerna gör tydligt att informationsförsörjning mellan regioners vårdinformationssystem och de Nationella Kvalitetsregistren ska ske via den nationellt gemensamma infrastrukturen och den av Inera AB framtagna tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Förutom en beskrivning av NKRR uppehåller sig promemorian vid vissa rättsliga överväganden för tjänsten. I dagsläget har SKR det övergripande förvaltningsansvaret för NKRR.

Sammanfattningsvis är bedömningen att en vårdgivares automatiserade utlämnande av personuppgifter till ett Nationellt Kvalitetsregister **genom NKRR** är en tillåten, och därmed laglig, behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen (PDL) och EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen), trots att utlämnandet kan innefatta ett överskott av personuppgifter för att genomföra en utfallsberäkning i registret.

1. BAKGRUND

- 1.1. Vårdgivares rapportering av uppgifter till Nationella Kvalitetsregister sker inte på ett tillräckligt resurseffektivt sätt idag. Många gånger handlar det om manuell rapportering, där vissa uppgifter först dokumenteras i vårdinformationssystem och sedan i de aktuella kvalitetsregister. Det råder en enighet inom den nationella kvalitetsregisterorganisationen om vikten av att så långt som möjligt automatisera rapporteringen av uppgifter från vårdgivare till kvalitetsregister. Det minskar den tidskrävande ”dubbeldokumentationen” samt ger förutsättningar för ökad täckningsgrad och mer fullständiga data i registren.

¹<https://skr.se/download/18.5627773817e39e979ef2696d/1642001889106/Inriktningsbeslut%20Nationella%20Kvalitetsregister%2020191105.pdf>



- 1.2. En förutsättning för en automatiserad informationsförsörjning av Nationella Kvalitetsregister är att informationen i vårdgivares vårdinformationssystem är strukturerad. Det bedrivs för tillfället ett flertal genomförandeprojekt i landet för automatiserad informationsförsörjning under ledning av den Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation och Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.
- 1.3. En ytterligare förutsättning är användning av gemensamma standarder såsom kodverk och klassifikationer för att enhetligt bestämma de strukturerade underlagen i vårddokumentationen. En annan förutsättning är gemensam digital infrastruktur och förvaltning. Dessutom krävs ett systemstöd som kan överföra uppgifter från vårdinformationssystem till kvalitetsregister på ett helt eller delvis automatiserat och strukturerat sätt. En sådant systemstöd är NKRR.

2. VAD ÄR NKRR?

- 2.1. NKRR är en central digital tjänst utvecklad för att helt eller delvis automatiserat ombesörja utlämnande av uppgifter, inklusive personuppgifter, från vårdgivare till Nationella Kvalitetsregister på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. I stället för att varje kvalitetsregister skapar egna standarder och investerar i egna tekniska lösningar för informationsöverföring från anslutna vårdgivare, används en centraliserad tjänst som på många sätt liknar Inera AB:s nationella tjänster för både vårdgivare och invånare (se *bild 1*). NKRR använder för övrigt Inera AB:s nationella tjänsteplattform för överföring av uppgifter, vilket förutsätter att rapporterande vårdgivare är anslutna till plattformen. Alla regioner och en majoritet av kommunerna är anslutna till Inera AB:s tjänsteplattform, liksom deras privata vårdutförare genom indirekta anslutningar till lokala eller regionala it-system eller s.k. agenter, vilket är en stor fördel i sammanhanget.
- 2.2. Rapportering till kvalitetsregister över NKRR förlöper i två typiska scenarier. Ett delvis automatiserat förlopp, där hälso- och sjukvårdspersonal hos en vårdgivare loggar in i aktuellt kvalitetsregister och i ett registreringsformulär, per patient, begär hämtning av uppgifter från vårddokumentationen hos vårdgivaren för automatisk förifyllnad av fält, till hjälp för registrerande personal. Om patientens vård ska följas upp med vissa tidsintervaller, måste personalen utföra samma åtgärd igen. Detta är en vanlig lösning då data till ett formulärs alla fält inte finns att hämta med automatik utan en registrering även kräver kompletterande manuell ifyllnad av vissa fält.
- 2.3. Ett andra förlopp är ett helt automatiserat sådant och kan fortlöpa utan bistånd av hälso- och sjukvårdspersonal. Förutsättningen är att vårdgivarens vårddokumentationssystem kan generera utlämnandebeslut med automatik utifrån gjord dokumentation. I detta förlopp går vårdinformationssystemet igenom dokumentationsunderlag och identifierar automatiskt de patienter som uppfyller



gällande krav för registrering. Samtidigt görs även kontroll att berörda patienter inte motsatt sig registrering. Har vårdgivaren flera registreringsförlopp automatiserade, kanske till flera kvalitetsregister, så är villkoren för uppfyllnad specifika för varje enskild registreringstyp. Därefter följer att vårdgivarsystemet meddelar respektive berört register om respektive önskad registrering. Det sker via s.k. notifiering till kvalitetsregistren, ett minimalt meddelande som skickas till berört register om önskad registrering av angiven patient. Det kvalitetsregister som tagit emot en notifiering fullföljer automatiskt den önskade patientregistreringen med anrop till vårdgivaren via NKRR.

Kvalitetsregistersystemet verkställer således med automatik hela den avsedda registreringen via anrop över Nationell tjänsteplattform. Både vårdgivares anrop till kvalitetsregister avseende notifiering inklusive kvalitetsregisters anrop till NKRR och vårdgivares inhämtning av underlag till registrering går över Inera AB:s nationella tjänsteplattform via anrop till tjänstekontrakt.

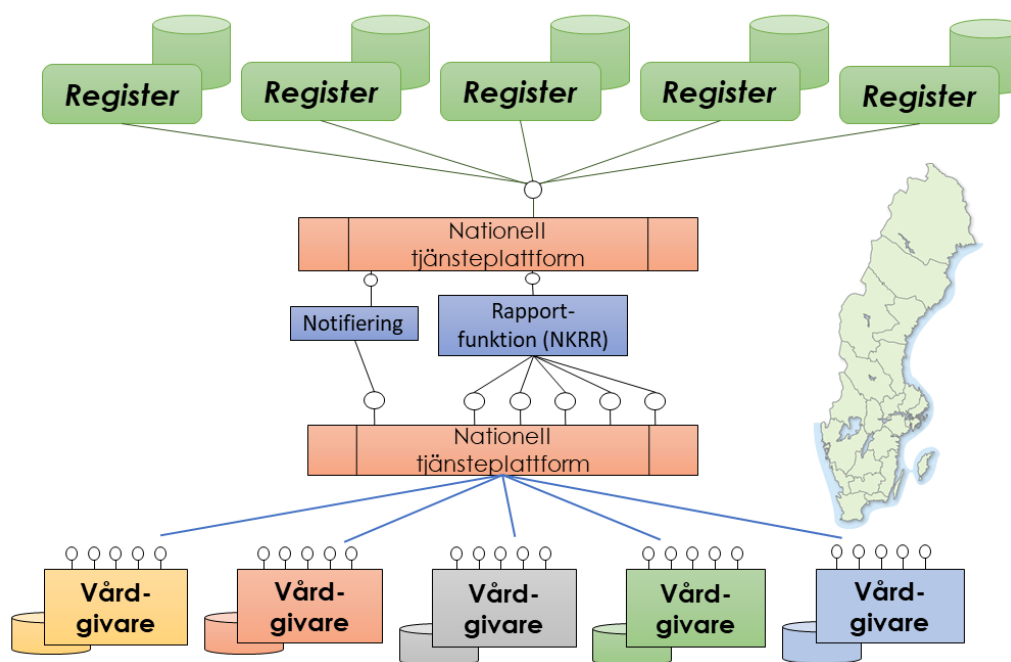


Bild 1. Nationell lösning för datainsamling till kvalitetsregister (NKRR).

- 2.4. NKRR förvaltas av SKR. Driften av tjänsten sker hos Västra Götalandsregionen på uppdrag av SKR. Inera AB förvaltar tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister. Det är en s.k. infrastrukturjänst. Tjänsten hanterar själva överföringen, transporten, av uppgifter från en vårdgivares vårdinformationssystem till ett eller flera nationella eller regionala kvalitetsregister. Både huvudmän för kvalitetsregister, normalt en regionstyrelse, och vårdgivare kan ansluta till tjänsten.



- 2.5. Idag är ansvaret för de Nationella Kvalitetsregistren fördelat på tio av landets regioner, dvs. mindre hälften av alla regioner. Som regel är det en regionstyrelse som är centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet), dvs. den myndighet som juridiskt ansvarar för personuppgiftsbehandlingen i ett eller flera kvalitetsregister. Inom Region Stockholm ser situationen lite annorlunda ut. Ansvaret för Nationella Kvalitetsregister är spritt på olika förvaltningar samt regionägda vårdbolag (Karolinska universitetssjukhuset [KS], Stockholms läns sjukvårdsområdet [SLSO], Södersjukhuset och Danderyds sjukhus). Det totala antalet huvudmän är således 13. Antalet vårdgivare som rapporterar patientuppgifter till Nationella Kvalitetsregister, inte bara till ett register utan flera, uppgår till flera tusen.
- 2.6. NKRR överbryggar lokala lösningar och system hos både vårdgivare och kvalitetsregister. NKRR består i huvudsak av en regelmotor med en registerspecifik logik och programvara som är oberoende av vårdgivarnas olika lokala system och samlar allt i en gemensam central nod. Varje enskilt kvalitetsregisters aktuella informationsbehov är kartlagt i en informationsspecifikation, som beskriver registrets hela databehov enligt gemensam nationell standard. Det förutsätter i sin tur att vårdinformationssystemets data är strukturerad (kodad) på visst sätt. Ju bättre kodning vårdgivaren gjort, desto ”träffsäkrare” och effektivare dataöverföring. Med hjälp av informationsspecifikationen hämtar NKRR, med vårdgivares tillåtelse, grunddata från vårdgivares vårdinformationssystem och hanterar därefter centralt selektion, uträkningar, tolkningar samt sammanställning och format för lagring i kvalitetsregistret. Utlämnandet sker genom fråga-svar-funktionalitet där CPUA-myndigheten via s.k. tjänstekontrakt efterfråga specifika data och vårdgivarens informationssystem svarar med att lämna ut begärda uppgifter.
- 2.7. NKRR har en funktionalitet för att ”släcka” brister i vårdgivarens kodning. Dessa brister kan vara tekniska eller semantiska och kan vara hänförs till en mängd olika orsaker, såsom äldre systemlösningar, ostrukturerade informationsmängder, brister i kommunikationen om utdataleverans mellan CPUA-myndigheter för ett kvalitetsregister och vårdgivare. Konsekvensen av bristerna är att vårdgivaren tillgängliggör data som kvalitetsregistret inte efterfrågar. Hur den situationen hanteras behandlas längre fram i denna promemoria.

3. HUR ÄR NKRR AVTALSREGLERAD?

- 3.1. Genom NKRR har inte bara utmaningen med ett fragmenterat informationslandskap hanterats. Även avtalsregleringen har väsentligt reducerats med hänsyn till mängden vårdgivare respektive antalet kvalitetsregister och huvudmän för dessa. Avtalsregleringen i detta fall omfattar behandlingen av personuppgifter hos både vårdgivare och CPUA-myndigheter. Det rör sig således om s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Det följer av artikel 28 i EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen) att när uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en



annan rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsländernas nationella rätt som är bindande för personuppgiftsbiträdet med avseende på den personuppgiftsansvarige.

- 3.2. Bestämmelser om behandling av personuppgifter i regionala och nationella kvalitetsregister regleras i 7 kap. PDL. Av bestämmelserna i kapitlet framgår att CPUA-myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i ett eller flera kvalitetsregister som myndigheten ansvarar för. Vårdgivares personuppgiftsansvar regleras i 2 kap. PDL. Enligt bestämmelserna i kapitlet är vårdgivare personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som dessa utför. Det innebär för kvalitetsregisters del att vårdgivare är personuppgiftsansvariga för dels utlämnande av uppgifter till ett kvalitetsregister, dels den direktåtkomst som vårdgivaren har till egna registrerade uppgifter i registret.
- 3.3. Personuppgiftsbiträdesavtal ska inte tecknas mellan två aktörer som utbyter personuppgifter och är vardera personuppgiftsansvariga, såsom vårdgivare och CPUA-myndighet. Däremot aktualiseras personuppgiftsbiträdesavtal i kvalitetsregistersammanhang när exempelvis en CPUA-myndighet anlitar en leverantör av en registerplattform. Leverantören behandlar i en sådan situation personuppgifter för CPUA-myndighetens räkning.
- 3.4. Bakom NKRR står ett flertal personuppgiftsbiträden, tillika leverantörer. En sådan är Västra Götalandsregionens regionstyrelse som driftar NKRR. Inera AB är en annan (se ovan). Bolaget anlitar i sin tur underleverantörer (underbiträden). SKR är varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för NKRR utan har ett övergripande förvaltnings- och samordningsansvar. Avtalssituationen för NKRR framgår av *bild 2*. Varje CPUA-myndighet har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen för behandlingen av personuppgifter i NKRR. Regionstyrelsen har i sin tur tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträdet Inera AB för användning av nationella tjänsteplattformen. Varje region har vidare tecknat kundavtal och personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB för tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister (se ovan).
- 3.5. Som framgår utgår nuvarande avtalsmodell från att respektive CPUA-myndighet för ett eller flera Nationella Kvalitetsregister är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i NKRR. Varför en CPUA-myndighet, och inte en vårdgivare, anses personuppgiftsansvarig för tjänsten NKRR behandlas i nästa avsnitt.

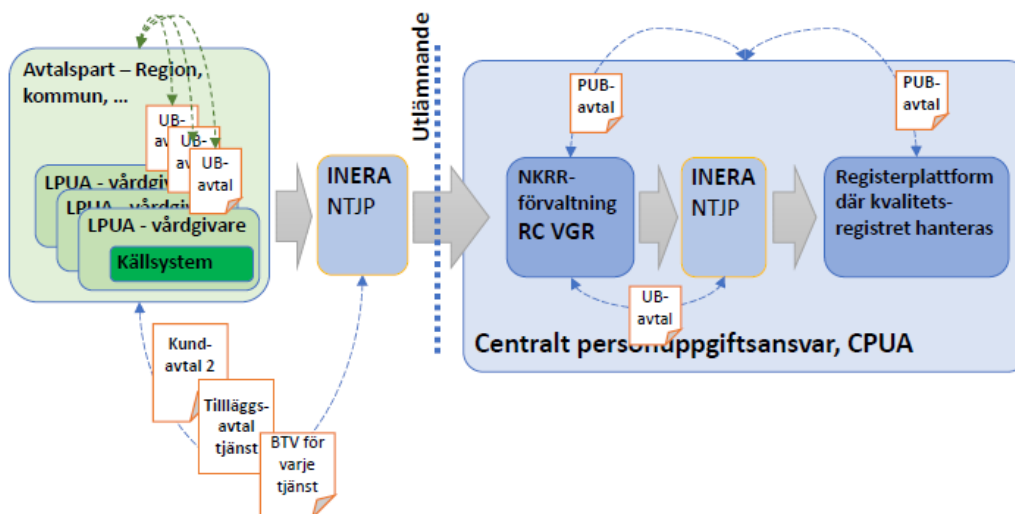


Bild 2. Avtalsmodell NKRR.

4. ÄR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER I NKRR TILLÅTEN?

PERSONUPPGIFTSANSVARET FÖR NKRR

- 4.1. Som framhållits är vårdgivare respektive CPUA-myndigheter, var och en, personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. En vårdgivares personuppgiftsansvar får anses omfatta både överföringen av personuppgifter till dess de tagits emot av ett kvalitetsregister (datarapportering) och den behandling som sker i samband med att medarbetare hos vårdgivaren tar del av vårdgivarens registrerade personuppgifter i registret (direktåtkomst). CPUA-myndigheten är personuppgiftsansvarig för mottagna uppgifter från vårdgivare och för den vidarebehandling som sker av dessa under dennes kontroll i registret.
- 4.2. NKRR är en "brygga" mellan vårdgivare och CPUA-myndigheten. Både vårdgivare och CPUA-myndigheter drar nytta av tjänsten på så sätt att vårdgivare kan expediera data till registret löpande på ett kostnadseffektivt sätt, medan CPUA-myndigheten får ett löpande inflöde av strukturerad data som uppfyller registrets inklusionskriterier. En fråga i sammanhanget är om både vårdgivare och CPUA-myndigheter har ett gemensamt personuppgiftsansvar eftersom deras behandling är tämligen sammanflätad och till bådas nytta. Bestämmelser om gemensamt personuppgiftsansvar finns i artikel 26 i dataskyddsförordningen. Emellertid är personuppgiftsansvaret för vårdgivare respektive CPUA-myndigheter författningsreglerat. Vårdgivares personuppgiftsansvar tar enbart höjd för de ändamål som en vårdgivare får behandla enligt 2 kap. 4 § PDL. CPUA-myndighetens personuppgiftsansvar tar enbart höjd för de ändamål som gäller



för behandling av personuppgifter i regionala och nationella kvalitetsregister enligt 7 kap. 4 och 5 §§ PDL. Det finns alltså inget utrymme för ett gemensamt personuppgiftsansvar.

- 4.3. Vad som återstår som alternativ är att antingen vårdgivare eller CPUA-myndigheter är ensamt personuppgiftsansvariga för NKRR. SKR har i denna del samrått med de regioner som är huvudmän för Nationella Kvalitetsregister. I samförstånd har CPUA-myndigheterna ansett sig bära personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som sker i NKRR. Skälen är följande.
- Behandlingen av personuppgifter i NKRR för ändamålet kvalitetssäkring (7 kap. 4 § PDL).
 - Det är CPUA-myndigheterna som skapar informationsspecifikationen i NKRR som efterfrågar relevanta uppgifter från varje ansluten vårdgivare.
 - Det är CPUA-myndigheterna i samverkan som utvecklat NKRR.
 - Det är CPUA-myndigheterna som ansvarar för tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder i NKRR.

Behandlingen av personuppgifter faller således till övervägande del under tillämpningsområdet för 7 kap. PDL. Det får till följd att respektive CPUA-myndighet är personuppgiftsansvarig för NKRR och ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

- 4.4. Varje vårdgivare är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifter till dess de utlämnats, eller hämtats, av tjänsten NKRR enligt det protokoll som tjänsten arbetar efter. Att NKRR hämtar efterfrågade uppgifter i vårdgivarens källsystem förändrar inte personuppgiftsansvaret för tjänsten. När ett tjänstekontrakt efterfrågar uppgifter hos en vårdgivare, och denne har accepterat tjänstekontraktets hämtande av uppgifter, får vårdgivaren anses ha lämnat ut uppgifterna genom automatiserade beslut. Vårdgivarens kontroll över uppgifterna anses upphöra, och därmed även personuppgiftsansvaret, i den stund de behandlas i NKRR och under CPUA-myndighetens kontroll. Processen är givetvis helt automatiserad. Den ”handskakning” som NKRR och vårdinformationssystemet gör innefattar ett flertal databehandlingar och kontroller av komplex natur. NKRR förutsätter därför att parterna har tilltro till varandra och om syftet med personuppgiftsbehandlingen. Tilltron följer av den samverkan regionerna ingått med SKR och de strategier som vägleder arbetet.
- 4.5. En annan fördel med att CPUA-myndigheterna bär personuppgiftsansvaret för NKRR är att avtalsadministrationen kan hållas till ett minimum. Om envar vårdgivare som rapporterar personuppgifter till ett eller flera kvalitetsregister ansågs personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen i NKRR, skulle åtminstone varje region och kommun i landet behöva teckna avtal med regionstyrelsen i Västra



Götalandsregionen. Såvida regionernas privata vårdutförare inte indirekt kan ansluta till NKRR via regionernas egna it-system eller Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister, måste de också i rollen som personuppgiftsansvariga teckna personuppgiftsbiträdesavtal med regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Det skulle innebära hundratals eller tusentals vårdgivare som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Det skulle bli en ohållbar situation för alla berörda parter.

UTFALLSBERÄKNING

- 4.6. Som beskrivits kan en vårdgivare inte alltid åstadkomma en kodning som helt möter kvalitetsregistrets informationsspecifikation. För att säkerställa att inte för få eller bristfälliga data lämnas ut av en vårdgivare till kvalitetsregistret, konfigurerar vårdgivaren sin kodningen så att resultatet blir att vårdgivaren lämnar ut fler uppgifter från vårdinformationssystemet till kvalitetsregistret än vad som behövs. Detta överskott av uppgifter hanteras av NKRR. Tjänsten applicerar ett mer finmaskigt regelverk på uppgifterna och sorterar ut de som är relevanta och ”kastar” de uppgifter som är överflödiga. De raderas helt enkelt. Denna process benämns *utfallsberäkning*. Processen är en ögonblickshändelse. Utfallsberäkningen omfattar inte invånare som motsatt sig registrering i ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister. Dessa håller respektive vårdgivare reda på i eget vårdinformationssystem genom spärrar.
- 4.7. Vårdgivarens utlämnande av ett överskott av data till kvalitetsregistret i dessa situationer av tillgängliggörande kan framstå som ett förfarande som står i strid med dataskyddsförordningens dataskyddsprinciper, såsom principen om uppgiftsminimering (art. 5.1 c). Enligt denna princip ska uppgifter vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
- 4.8. Av skäl 39 i dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter bör endast behandlas om syftet med behandlingen inte rimligen kan uppnås genom andra medel. För närvarande går det inte att med rimliga medel råda bot på brister i vårdgivares källsystem som resulterar i ”läckage” och utfallsberäkningar på annat sätt än som sker nu i NKRR. Det går inte alltid att koda data i sådan utsträckning att ett utlämnande exakt motsvarar kvalitetsregistrets behov av data.
- 4.9. Frågan är om en vårdgivares utlämnande av ett överskott av uppgifter till CPUA-myndigheten är i strid med dataskyddsregleringen. Är utlämnandet nödvändigt för ändamålet kvalitetssäkring? PDL reglerar inte närmare vårdgivares utlämnande av uppgifter till kvalitetsregister för vidarebehandling. Av 7 kap. framgår enbart att personuppgifter får samlas in av flera vårdgivare till kvalitetsregister (7 kap. 1 § PDL). Några särskilda krav uppställs inte på uppgiftslämnandet. I stället får svaret på frågan



om överskottsuppgifter sökas i dataskyddsförordningens bestämmelser som är tillämpliga på utlämnandebehandlingen.

FINALITETSPRINCIPEN

- 4.10. Som framhållits sker vårdgivarens utlämnande av personuppgifter till NKRR, tillika CPUA-myndigheten, i vissa fall för ändamålet utfallsberäkning. Det sker när vårdgivarens data beroende på kodning behöver ”kureras” av CPUA-myndigheten innan dessa registreras i registret.
- 4.11. Av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen framgår den så kallade finalitetsprincipen. Principen innebär att personuppgifter som samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål inte senare får behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Finalitetsprincipens syfte är att förhindra samkörningar av stora datamängder eller registrerade samt förhindra ändamålsglidningar. Principen har dock undantag. Dessa framgår av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Vidarebehandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen anses inte vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen som uppgifterna samlades in för. Kvalitetssäkring är dock inte omnämnt i artikeln.
- 4.12. I artikel 6.4 i dataskyddsförordningen anges vilken bedömning den personuppgiftsansvarige ska göra för att fastställa om en vidarebehandling för andra ändamål är förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in, s.k. oförenlighetsprövning. I artikeln anges vad den personuppgiftsansvarige ska beakta om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in inte grundar sig på den registrerades samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1 i dataskyddsförordningen.
- 4.13. Enligt artikel 6.4 ska den personuppgiftsansvarige beakta kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen, det sammanhang inom vilket personuppgifter har samlats in, särskilt förhållandet mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige, personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 i dataskyddsförordningen eller huruvida personuppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i enlighet med artikel 10 i dataskyddsförordningen, eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen samt förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan innebära kryptering eller pseudonymisering.



- 4.14. Av skäl 50 till dataskyddsförordningen framgår att vid behandling som inte hindras av finalitetsprincipen krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs. Detta är en nyhet i förhållande till det tidigare dataskyddsdirektivet.
- 4.15. Enligt 2 kap. 5 § PDL får en vårdgivare behandla personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i lagens ändamålsbestämmelser (2 kap. 4 § PDL), under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Finalitetsprincipen är således tillämplig på en vårdgivares behandling av personuppgifter. Ändamålet för regionala och nationella kvalitetsregister är kvalitetssäkring, dvs. systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av vårdens kvalitet. Det primära syftet är således att följa upp medicinsk och annan kvalitet i själva vårdinsatserna. En vårdgivares vidarebehandling av personuppgifter i syfte att försörja ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med personuppgifter får således anses förenlig med dataskyddsförordningen och 2 kap. 4 och 5 §§ PDL. Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).
- 4.16. För att behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen krävs också att behandlingen är *nödvändig* för att utföra uppgiften av allmänt intresse (artikel 6.3). Detta ska inte tolkas som att uppgiften av allmänt intresse måste vara avgränsad så att den bara kan utföras på ett sätt. Den metod som den personuppgiftsansvarige väljer för att utföra sin uppgift måste dock – som all offentlig förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och får därmed inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv. Kravet på att ändamålet ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse innebär i sig en spärr mot helt onödigt behandling av personuppgifter eller sådan behandling som utgör ett oproportionerligt intrång i privatlivet som inte kunnat förutses (prop. 2017/18:105 s. 60).
- 4.17. Något utrymme för CPUA-myndigheten att tillämpa finalitetsprincipen på personuppgifter i ett kvalitetsregister finns dock inte. Det framgår av 7 kap. 6 § PDL. Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 7 kap. 4 och 5 §§ PDL. Begränsningen innebär att det är bara tillåtet att registrera personuppgifter i ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister för det primära ändamålet kvalitetssäkring. En innebörd av begränsningen är att personuppgifter inte får registreras enbart för att användas för forskning. Inga andra ändamål är tillåtna, även om dessa inte är oförenliga med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in, dvs. kvalitetssäkringsändamål (proposition 2007/08:126 s. 180).



LAGLIGHETSPRÖVNING AV UTFALLSBERÄKNINGAR

- 4.18. Är vårdgivares utlämnande av personuppgifter till utfallsberäkning i NKRR en förenlig behandling av personuppgifter med det primära ändamålet kvalitetssäkring i ett Nationellt Kvalitetsregister? Att data är korrekta eller kompletta i ett kvalitetsregister är av synnerligen stor betydelse för en vårdgivares lokala förbättringsarbete och för framställning av statistik på ett sjukdoms- eller åtgärdsområde. CPUA-myndigheter utför löpande sådana kvalitetskontroller. Det är ingen kontroll av kvaliteten i själva vårdinsatserna utan syftar till att säkra kvaliteten i data, här benämnd *registerkvalitet*.
- 4.19. Ett sätt att kontrollera kvaliteten i data är att samköra register. Kvalitetsregister samkörs idag regelbundet mot Socialstyrelsens hälsodataregister och dödsorsaksregister, både för att ta fram täckningsgradsjämförelser men även för att titta på andra uppföljningar med syfte att öka registerkvaliteten. Dödsorsaker kan lämnas ut av Socialstyrelsen med den avlidnes identitet tack vare en sekretessbrytande bestämmelse (24 kap. 8 § 3 stycket offentlighets- och sekretesslagen), medan den övriga samkörningen lämnas ut i form av statistik. Sådana analyser sker alltså inte för ändamålet forskning utan för kvalitetssäkring av uppgifterna i kvalitetsregistret (registerkvalitet). Övervägande skäl talar för att kvalitetssäkringsändamålet i 7 kap. 4 § PDL rymmer behandlingar som i slutändan syftar till att säkerställa en god registerkvalitet i kvalitetsregistren. Säkerställande av registerkvalitet är alltså ett led i behandlingen av personuppgifter i kvalitetsregister för ändamålet kvalitetssäkring.
- 4.20. Bortfallsanalys är ett annat exempel på registerkvalitet. Bortfallsanalyser är ett nödvändigt instrument för att kunna kvalitetsdeklarera och beskriva resultatet av en statistisk undersökning. Bortfallsanalysen avser de personer som inte deltagit i en statistisk undersökning till vilken de utvalts. Det ligger därmed i sakens natur att bortfallsanalys normalt inte kan ske med personens samtycke. Regeringen har ansett att gällande rätt innebär att bortfallsanalyser kan göras när behovet av det kan karaktäriseras ”som ett allmänt intresse” (prop. 2000/01:27 s. 53). Framställning av officiell statistik utgör ett sådant allmänt intresse, enligt regeringen. Bortfallsanalyser utgör således ett led i framställning av statistik.
- 4.21. Det primära ändamålet kvalitetssäkring för regionala och nationella kvalitetsregister är till sin karaktär övergripande och möjliggör därmed en bredd av olika behandlingar av personuppgifter i olika register. Detta primära ändamål ska i sin tur brytas ner i mer preciserade ändamål som är anpassade för varje särskilt register och det medicinska specialområde eller motsvarande som avses täckas med registret (prop. 2007/08:126 s. 179). Det primära ändamålet rymmer emellertid också behandlingar som syftar till att säkerställa registerkvalitet, såsom utfallsberäkningar. Utfallsberäkningar är alltså inte ett nytt eller särskilt ändamål utan ett och samma ändamål – kvalitetssäkring.



- 4.22. I de fall en vårdgivares kodning av de uppgifter som ska lämnas ut till ett kvalitetsregister inte når upp till de kvalitetskrav som registret ställer på data, ”kureras” dessa av CPUA-myndigheten genom utfallsberäkningen i NKRR. Utfallsberäkningen sker för ändamålet kvalitetssäkring och är nödvändig och proportionerlig i förhållande till det ändamålet. I vart fall är behandlingen inte oförenlig med ändamålet kvalitetssäkring i 7 kap. 4 § PDL med hänsyn till den avsedda ytterligare behandlingen, att mottagaren är en myndighet inom hälso- och sjukvården, att mottagande CPUA-myndigheter ska iaktta dataskyddsförordningens dataskyddsprinciper, att registrerade har en rätt att motsätta sig registrering, att ett nära samarbete föreligger mellan vårdgivare och CPUA-myndigheten, att skyddsåtgärder i form av radering av icke relevanta data sker och att kvalitetsregister är till nytta för patientkollektivet. Några negativa konsekvenser av utfallsberäkningen finns inte för registrerade.
- 4.23. Vid en sammantagen bedömning är vårdgivares automatiserade utlämnande av personuppgifter till en CPUA-myndighet genom NKRR en tillåten, och därmed laglig, behandling av personuppgifter enligt PDL och dataskyddsförordningen, även när utlämnandet innefattar i vissa fall en utfallsberäkning.